



1er Congrès de Biologie Médicale de Sétif (CBMS), 24 et 25 Octobre 2026 Profil clinique, sérologique et histologique de la maladie cœliaque chez l'adulte.

I. DALICHAOUCHÉ¹, A. ABDENNOUR²

¹ Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Université Constantine 1 Frères Mentouri.

² Cabinet privé d'Hépatogastroentérologie, El Khroub, Constantine.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

La maladie cœliaque (MC), affection auto-immune déclenchée par le gluten, touche ~1% de la population [1]. Chez l'adulte jeune, les formes atypiques retardent souvent le diagnostic [2], tandis que les transitions de vie compliquent l'observance du régime sans gluten (RSG). Toutefois, la MC reste sous-documentée en Algérie. Ce contexte justifie la nécessité de caractériser les profils clinico-biologiques et histologiques des jeunes adultes cœliaques de notre population, afin d'identifier les facteurs influençant la sévérité de l'atteinte intestinale et la réponse au RSG.

RESULTATS

Profil épidémio-clinique

Sexe: 88,3 % de femmes. Âge moyen: 35 ans $\pm$ 10.08

Clinique :

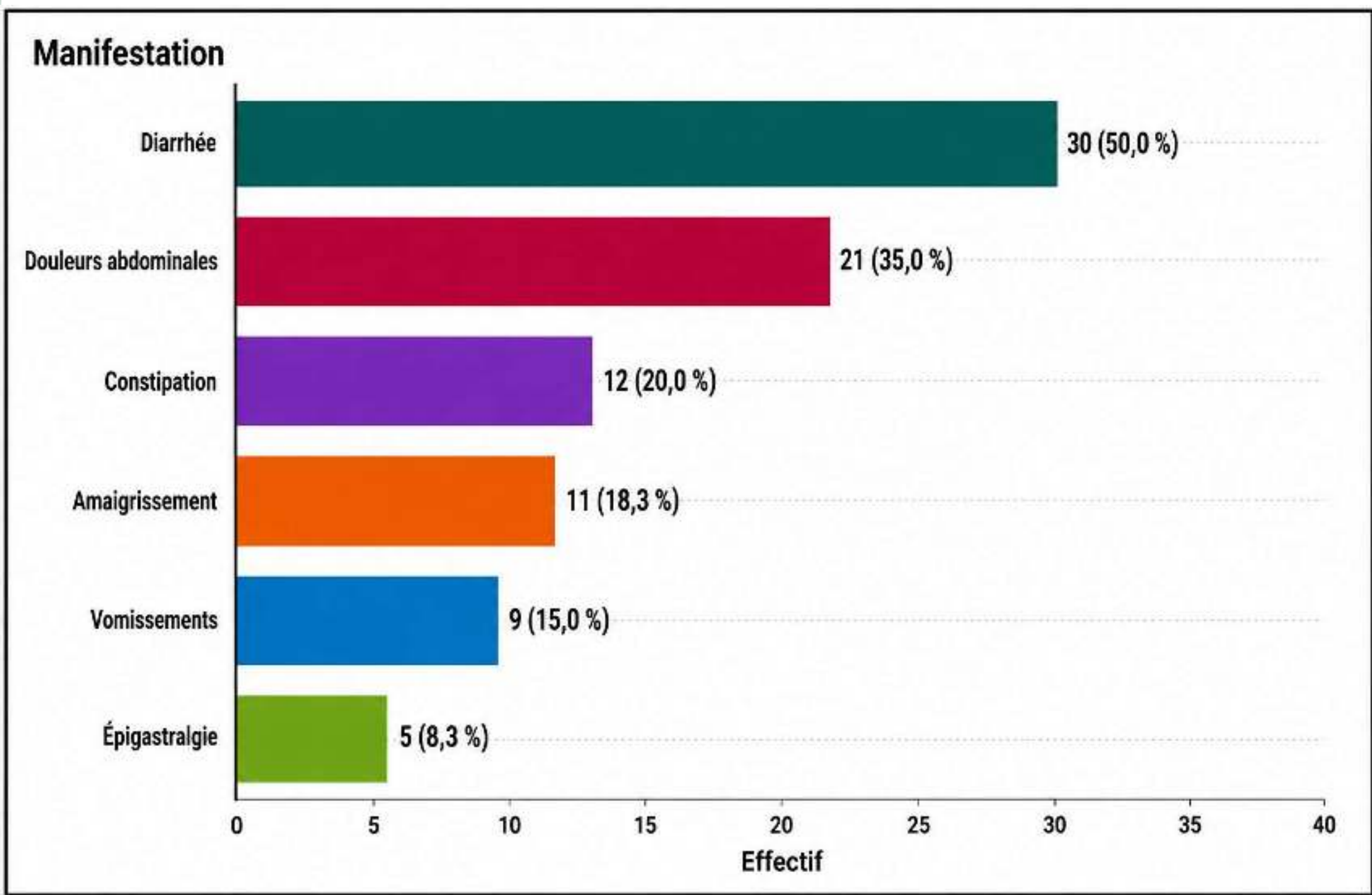


Figure 1. Distribution des manifestations digestive

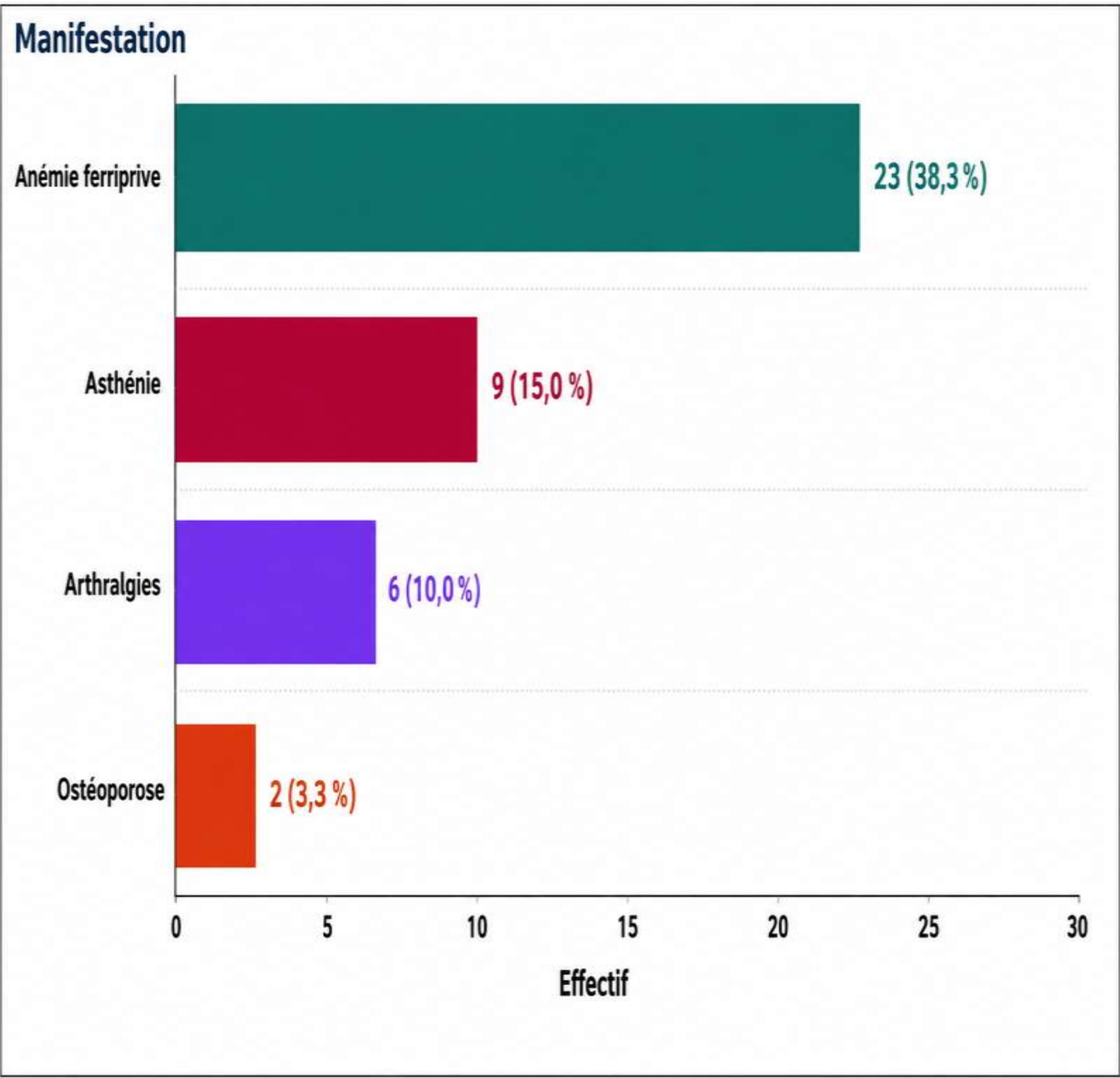


Figure 2. Distribution des manifestations extra-digestive

Grades d'atrophie villositaire:

✓ Lésions avancées (Marsh 3b/3c) dans > 70 % des cas au diagnostic.

• **Sérologie:** Les IgA sont positives chez 80 % des patients, et les IgG chez 53,3 %.

• **Génétique/Comorbidités :** Antécédents familiaux directs (26,7 %), maladies auto-immunes associées (20 %).

Évolution sous RSG:

• Efficacité globale : 90 % de réponses cliniques satisfaisantes.

• Facteur prédictif : L'âge est le seul facteur lié à une bonne réponse au RSG (36,3 vs 26,3 ans ; $p = 0,014$).

• **Facteurs associés à la sévérité histologique:** Pas de corrélation entre les symptômes/sérologie et l'atrophie. L'âge est le seul facteur influençant la sévérité histologique ($p = 0,033$).

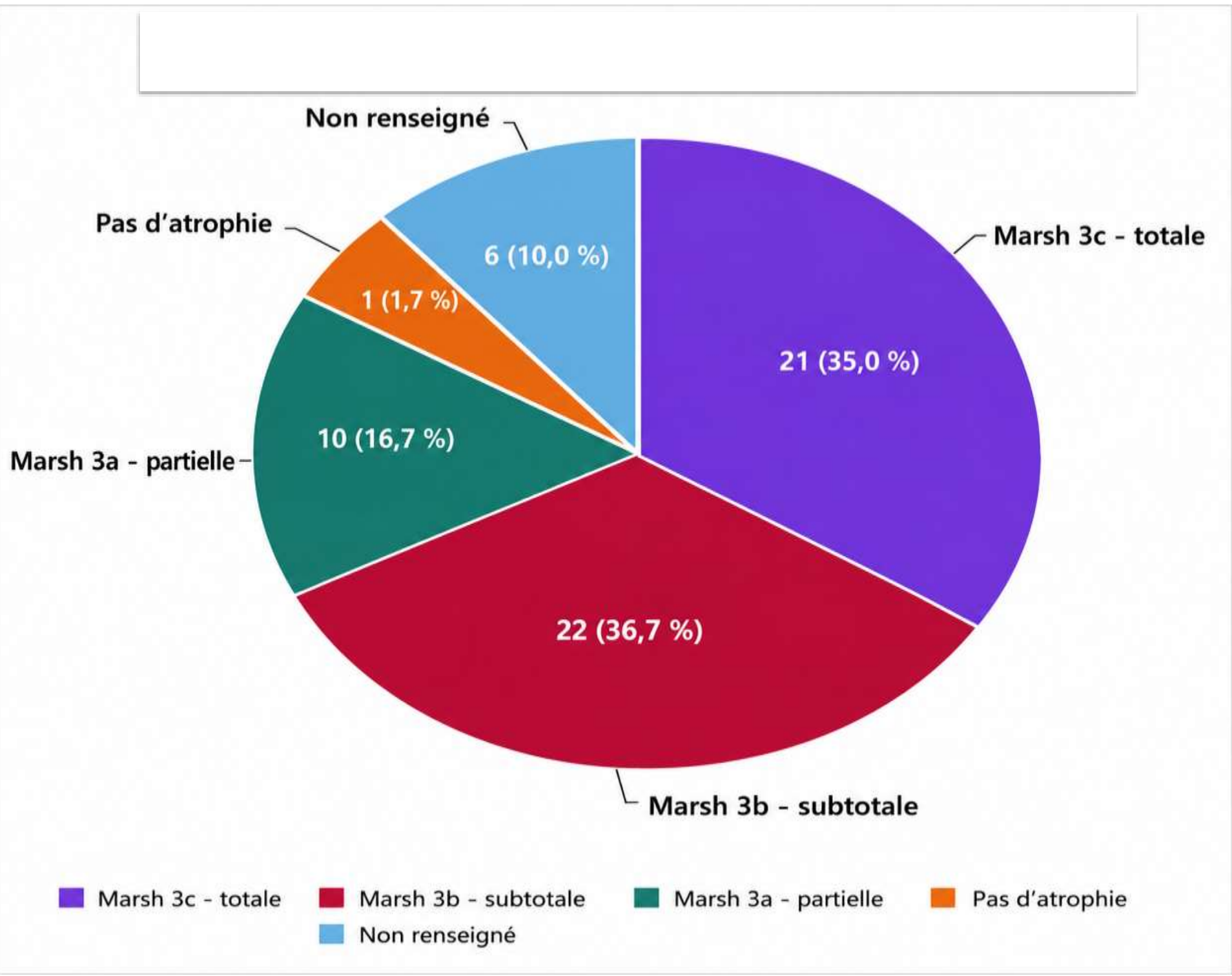


Figure 3. Différents stades de l'atrophie villositaire

CONCLUSION

Cette étude souligne les spécificités de la maladie cœliaque de l'adulte dans l'Est algérien : prédominance féminine et diagnostic tardif (âge moyen : 35,0 $\pm$ 10,08 ans) marqué par de sévères lésions histologiques (Marsh 3b/3c). La confirmation d'une dissociation clinico-histologique impose un dépistage systématique par la sérologie devant toute manifestation atypique (ex. anémie ferriprive). Si le régime sans gluten reste très efficace, l'âge est le seul facteur prédictif d'une bonne observance. Ces résultats plaident pour un renforcement de l'éducation thérapeutique et la réalisation d'études multicentriques avec volet immunogénétique pour optimiser la prise en charge en Algérie.

REFERENCES

- Poslt Königová M, Sebalo Vňuková M, Řehořková P, Anders M, Ptáček R. The effectiveness of gluten-free dietary interventions: A systematic review. *Front Psychol.* 2023;14:1107022.
- Caio G, Volta U, Sapone A, et al. Celiac disease: A comprehensive current review. *BMC Med.* 2019;17(1):142.
- Rubio-Tapia A, Hill ID, Semrad C, et al. American College of Gastroenterology Guidelines Update: Diagnosis and Management of Celiac Disease. *Am J Gastroenterol.* 2023;118(1):59-76.
- Mehta S, Agarwal A, Pachisia AV, et al. Impact of delay in the diagnosis on the severity of celiac disease. *J Gastroenterol Hepatol.* 2024;39(2):256-263.
- Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2020;70(1):141-156.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

***Étude et Population:** Rétrospective, descriptive et analytique (N = 60).

Patients adultes (≥ 18 ans) atteints de MC.

***Cadre et Période:** Cabinet de gastro-entérologie, El Khroub (Algérie), 2023 - 2026.

***Critères:** Dossiers complets inclus (cliniques, sérologiques, histologiques); dossiers incomplets ou perdus de vue exclus.

***Paramètres étudiés:** Profil épidémiologique, manifestations digestives/extra-digestives, bilan biologique, grade d'atrophie villositaire, comorbidités et évolution sous RSG.

* **Analyse statistique:** Stata v27. Variables quantitatives en médianes (distribution non normale). Tests : Khi-deux, Fisher, Mann-Whitney, Spearman, régression logistique. Seuil : $p < 0,05$.

DISCUSSION

L'étude met en lumière les spécificités de la maladie cœliaque chez l'adulte jeune, soulignant l'importance du contexte clinique et démographique.

La forte prédominance féminine (88,3 %) et l'âge moyen au diagnostic (35,3 ans $\pm$ 10.08 ans) concordent avec certaines données de la littérature [3]. Bien que les symptômes digestifs classiques (diarrhée: 50%) prédominent, la fréquence élevée de l'anémie ferriprive (40%) confirme l'importance des manifestations extra-digestives, retardant souvent le diagnostic.

Les IgA sont positives chez 80 % des patients, et les IgG chez 53,3 %. Une sérologie positive est associée à une meilleure réponse au régime sans gluten.

La proportion majeure de lésions avancées (> 70 % de Marsh 3b/3c) reflète un retard diagnostique significatif, s'expliquant par une exposition prolongée au gluten liée à des présentations atypiques [4].

L'absence de corrélation entre la sévérité des symptômes (digestifs ou extra-digestifs), l'IMC ou la sérologie, et le degré d'atrophie villositaire (Marsh 3c) renforce l'idée que la sévérité clinique ne prédit pas l'atteinte muqueuse.

La prévalence des comorbidités auto-immunes (20 %) et des antécédents familiaux (26,7 %) confirme la forte agrégation génétique (HLA-DQ2/DQ8), justifiant le dépistage systématique chez les apparentés du premier degré.

L'efficacité globale du régime sans gluten est excellente (90 %) [5]. L'âge est le seul facteur prédictif significatif d'une bonne réponse thérapeutique ($p = 0,014$), suggérant une meilleure observance, compréhension et maturité chez les patients plus âgés.